Faculté de Médecine de Mostaganem · 5■ année

Prise en charge des lésions traumatiques en Médecine Physique et de Réadaptation

Cours reconstruit à partir de la banque de QCM : tout ce qu'il faut comprendre pour répondre aux questions, rien de superflu.

Comment lire ce cours
TOMBE EN QCM signale un point déjà posé en QCM ; le chiffre ×N indique la fréquence dans la banque. ★★★ ≥ 6 questions, ★★ 3 à 5, ★ moins de 3.
✔ = proposition juste · ✘ = proposition fausse (pièges).

Sources : Cours Pr F. BENLEBNA (MPR – CHU Mostaganem) + Banque QCM OTR (≈ 70 questions rééducation / MPR / traumatologie).

Les 10 points à connaître avant tout

1 La MPR est un **complément thérapeutique indispensable** en traumatologie. L'objectif prioritaire est la **récupération de la fonction** (pas seulement la restauration anatomique).

2 Objectifs phase aiguë : prévenir complications du décubitus et douleur, prévenir attitudes vicieuses / enraidissement / fonte musculaire, favoriser l'indépendance fonctionnelle.

3 Objectifs phase secondaire : récupérer amplitudes et force maximales, capacités fonctionnelles optimales, compenser déficits irréversibles, prévenir complications à moyen/long terme.

4 Bilan MPR : tropho-cutané, orthopédique (attitudes vicieuses), articulaire (goniomètre), neuromusculaire (testing 0–5), fonctionnel (préhension, marche, AVQ), psychologique.

5 Moyens phase aiguë : installation au lit (alignement), nursing, **lever précoce**, cryothérapie +++ pour la douleur, mobilisations passives puis actives, orthèses de posture.

6 Trois grands traitements : fonctionnel (reprise de fonction), orthopédique (plâtre/résine/traction — pas de risque anesthésique/infectieux mais long), chirurgical (appui plus rapide mais risques).

7 Techniques de base : kinésithérapie, ergothérapie, orthoprothésie. Progression : analytique → fonctionnel. Auto-rééducation + motivation du patient indispensables.

8 Rééducation proprioceptive, renforcement (statique/dynamique, CCF/CCO), physiothérapie (US, électrothérapie), thermo-cryothérapie.

9 Protocoles spécifiques importants : LCA post-op (DIDT/KJ) — phases cicatrisation / ligamentisation (CCF privilégiée) / fonctionnelle / réathlétisation (Hop Tests, isocinétisme) sur 6–9 mois.

10 Règle d'or : rester dans les limites de la tolérance de la douleur (éviter le cercle vicieux douleur–raideur). Coopération patient – médecin MPR – chirurgien.

Ce qui tombe le plus

Thème	Fréq.	Priorité
Objectifs phase aiguë vs secondaire	≈ 8	★★★
Rôle de la MPR / récupération de la fonction	≈ 7	★★★
Bilan clinique MPR (testing, goniomètre…)	≈ 6	★★★
Moyens phase aiguë (lever précoce, cryothérapie, orthèses)	≈ 6	★★★
Orthèses / aides techniques / cannes	≈ 5	★★
Traitement fonctionnel / orthopédique / chirurgical	≈ 4	★★
Protocoles LCA / ligaments / tendons	≈ 3	★★
Complications (algodystrophie, cal vicieux, raideur)	≈ 4	★★

Sources : cours Pr Benlebna (MPR) + Banque QCM OTR

1 · Définition, objectifs et principes TOMBE EN QCM ×7 ★★★

La rééducation en traumatologie vise à redonner un fonctionnement locomoteur le plus proche possible de l'état physiologique, en corrigeant les conséquences (atrophie, instabilité) ou en luttant contre les états morbides (immobilisation, désadaptation à l'effort).

Objectifs généraux : soulager la douleur, récupérer l'amplitude articulaire, récupérer la force musculaire, retrouver une bonne qualité de vie + éducation pour éviter les récidives.

Principe clé : exercices spécifiques + motivation du patient + auto-rééducation + coopération patient / médecin MPR / chirurgien. Protocoles standardisés, consensuels et reproductibles.

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×7
✔ La MPR est un complément thérapeutique indispensable en traumatologie
✔ La récupération de la fonction est l'objectif prioritaire
✔ Elle peut réadapter l'environnement à la situation de handicap du patient
✔ Elle s'attaque au handicap produit par le traumatisme
✘ Le résultat est mieux acquis par la restauration anatomique plutôt que par la récupération de la fonction
✘ Le résultat ne dépend pas de la précocité du traitement rééducatif

2 · Objectifs selon la phase TOMBE EN QCM ×8 ★★★

Phase	Objectifs
Aiguë (hospitalisation)	1. Prévenir les complications liées au décubitus et à la douleur 2. Favoriser l'indépendance fonctionnelle 3. Prévenir attitudes vicieuses, enraidissement articulaire et fonte musculaire
Secondaire	1. Récupérer amplitudes articulaires et force musculaire maximales 2. Retrouver capacités fonctionnelles optimales (réinsertion sociale) 3. Compenser les déficits irréversibles 4. Prévenir les complications à moyen et long terme

CE QUI EST TOMBÉ TOMBE EN QCM ×8
✔ Phase aiguë : prévenir complications du décubitus et douleur + attitudes vicieuses + fonte musculaire
✘ Récupérer amplitudes et force maximales = objectif de phase aiguë (c'est la phase secondaire)
✘ Rééducation proprioceptive = objectif principal de la phase aiguë

3 · Bilan en MPR TOMBE EN QCM ×6 ★★★

Bilan clinique

- Interrogatoire (médical + social + douleur)
- Bilan tropho-cutané
- Bilan orthopédique / attitudes vicieuses
- Bilan articulaire chiffré (goniomètre)
- Bilan neuromusculaire : testing musculaire de 0 à 5
- Bilan fonctionnel : préhensions, marche, AVQ
- Bilan général + psychologique

Bilan paraclinique : radiographies, biologie, liquide de ponction, TDM/IRM selon besoin.

Réaliser un **bilan initial et un bilan final** pour chaque prise en charge.

Sources : cours Pr Benlebna + Banque QCM OTR

4 · Les trois types de traitement TOMBE EN QCM ×4 ★★

Type	Principe	Avantages / Inconvénients
Fonctionnel	Reprise de la fonction	—
Orthopédique	Immobilisation (plâtre, résine, thermoformable, traction)	Avantages : pas de risque anesthésique ni infectieux Inconvénient : traitement long
Chirurgical	De plus en plus fréquent	Avantage : appui parfois plus rapide, évite souvent l'immobilisation Risques : anesthésique + infectieux

5 · Moyens de la phase aiguë TOMBE EN QCM ×6 ★★★

Prévention des complications du décubitus, de la douleur et des attitudes vicieuses

a. Installation au lit : bon positionnement et alignement articulaire
b. Nursing : cutané, orthopédique, urinaire…
c. **Lever précoce** (avec ou sans contention) → évite œdème, phlébite, hypotension orthostatique
d. Traitement de la douleur : médical + physique (**cryothérapie +++**)

Favoriser l'indépendance fonctionnelle

• Déambulation sur fauteuil roulant
• Marche avec aides techniques, simulation du pas, barres parallèles, cannes sous-axillaires
• Membre supérieur : positionnement en position de fonction (orthèses de posture)

Entretien / gain d'amplitude et renforcement

• Mobilisation passive (manuelle, attelle motorisée, auto-posture)
• Mobilisation active globale ou analytique (aidée → résistée)

6 · Moyens de la phase secondaire TOMBE EN QCM ×4 ★★

• Massage (classique, réflexe…)
• Physiothérapie : ultra-sons, électrothérapie
• Thermo-cryothérapie : packs chauds/froids, paraffine, parafango, cryospray, bains écossais (37°/15°)
• Mobilisations passives et actives
• Renforcement musculaire statique ou dynamique, global ou analytique
• Rééducation proprioceptive
• Aides techniques / orthèses / cannes (faciliter déambulation ou mise en décharge)

CE QUI EST TOMBÉ

✔ Lever précoce évite œdème, phlébite, hypotension orthostatique
✔ Cryothérapie = moyen physique antalgique majeur en phase aiguë
✔ Une orthèse peut se porter aux MI, MS et tronc ; peut pallier une déficience ; ne remplace pas un segment de membre

Sources : cours Pr Benlebna + Banque QCM OTR

7 · Protocoles selon pathologies TOMBE EN QCM ×3 ★★

A. Rupture du LCA (post-opératoire — DIDT ou Kenneth-Jones) — 6 à 9 mois

Phase	Période	Objectifs / Moyens
Cicatrisation	Mois 1	Verrouillage actif du quadriceps (lutte contre la sidération), extension complète passive impérative, flexion ≤ 90°, marche sans béquilles
Ligamentisation (fragilité du greffon)	Mois 2–3	Renforcement en **chaîne cinétique fermée** (presse, squat léger). Travail en chaîne ouverte (leg extension) proscrit ou très encadré
Fonctionnelle	Mois 4–6	Vélo extérieur, reprise course à pied (si tests validés), pliométrie basse
Réathlétisation	Mois 6–9	Pivots/contacts, isocinétisme, Hop Tests → validation Return to Play

B. Lésions traumatiques des tendons de la main suturés

- Immobilisation en position de détente du tendon pendant 6 semaines (cicatrisation)
- Puis mobilisations articulaire activo-passives
- Renforcement musculaire statique puis dynamique
- Travail proprioceptif en fin de protocole

8 · Règles générales de prescription et pièges TOMBE EN QCM ×3 ★

- Tenir compte de la nature de la lésion, de la fonction de la structure lésée, des besoins fonctionnels et du niveau sportif du patient.
- Rester dans les limites de la tolérance de la douleur → une rééducation forcée entraîne le cercle vicieux **douleur / raideur**.
- Motivation du patient + auto-rééducation indispensables (programme souvent long).
- Coopération complète patient – médecin MPR – chirurgien.

Complications souvent testées en QCM liées à la rééducation / traumatologie

- Algodystrophie (surtout fractures extrémité inférieure du radius chez la femme âgée)
- Cal vicieux, pseudarthrose, raideur du genou (fractures diaphyse fémorale)
- Attitudes vicieuses si mauvais positionnement

Sources : cours Pr Benlebna + Banque QCM OTR

Fiche express — À retenir pour les QCM

Objectifs phase aiguë vs secondaire — mémo express

Aiguë = prévenir (décubitus, douleur, attitudes vicieuses, fonte, enraidissement) + indépendance
Secondaire = récupérer (amplitudes, force, fonction) + compenser + prévenir long terme

Bilan MPR — les 7 piliers

Tropho-cutané · Orthopédique (attitudes) · Articulaire (goniomètre) · Neuromusculaire (testing 0–5) · Fonctionnel (AVQ, marche) · Général · Psychologique

LCA post-op — les 4 phases en 1 ligne

M1 cicatrisation (extension complète + verrouillage quad) → M2-3 CCF (protéger greffon) → M4-6 course/vélo → M6-9 Hop Tests / RTP

Les pièges classiques des QCM

- ✘ Objectif phase aiguë = récupérer force et amplitudes maximales → non, c'est la phase secondaire
- ✘ Le résultat dépend surtout de la restauration anatomique → non, de la récupération de la fonction
- ✘ Le résultat ne dépend pas de la précocité → si, la précocité compte
- ✘ Une orthèse remplace un segment de membre → non (c'est la prothèse)
- ✘ Travail en chaîne ouverte précoce après LCA → proscrit ou très encadré (protéger le greffon)
- ✘ Rééducation forcée malgré la douleur → cercle vicieux douleur–raideur

Phrase de conclusion à retenir

L'objet de la MPR est de redonner un fonctionnement le plus proche possible de la physiologie, de diminuer les déficiences, réduire les incapacités et prévenir le handicap, dans les limites de la douleur, grâce à une coopération patient–médecin MPR–chirurgien et une auto-rééducation.

Techniques de base à ne pas oublier : kinésithérapie + ergothérapie + orthoprothésie. Progression analytique → fonctionnel. Cryothérapie en phase aiguë. Lever précoce. Orthèses de posture en position de fonction.

Sources : cours Pr F. Benlebna (MPR – CHU Mostaganem) + Banque QCM OTR (≈ 70 questions rééducation / traumatologie / MPR)